

PROFIL		MOLÉCULES		FORMES			EFFETS SECONDAIRES						
		DCI	Spécialité	BUV	INJ	LP	↗poids	sédation	extrapyram	↗prolact	antichol	HypoTA	↗QTc
ANTIPSYCHOTIQUES NEUROLEPTIQUES ATYPIQUES DE SECONDE GÉNÉRATION	Profil classique à doses élevées	Aripiprazole	ABILIFY®	+	+	+	+ / ++	+ / ++	++	+	+ / ++	+	+ / ++
		Clozapine	LEPONEX®	–	–	–	++++	++++	+	+	++++	++++	++
		Olanzapine	ZYPREXA®	–	+	+	++++	+++	++	++	+++	++	++
		Quétiapine	XEROQUEL®	–	–	–	+++	++++	+ / ++	+	+++	+++	+++
		Risperidone	RISPERDAL®	+	–	+	++	++	+++	++++	++	++	++
		Amisulpride	SOLIAN®	+	+	–	+ / ++	+ / ++	++	++++	++	+ / ++	+++
		Sulpiride	DOGMATIL®	+	–	–	+++	++	++	+++	+ / ++	+ / ++	++
		Tiapride	TIAPRIDAL®	+	+	–	++	++	++	+++	++	+ / ++	+++
		Loxapine	LOXAPAC®	+	+	–	++	+++	+++	+++	+++	+++	+ / ++
		Cyamémazine	TERCIAN®	+	+	–	+++	+++	++	++	++++	+++	++
NEUROLEPTIQUES CLASSIQUES DE PREMIÈRE GÉNÉRATION	Profil atypique à faibles doses	Chlorpromazine	LARGACTIL®	+	+	–	+++	+++	+++	++	++++	++++	+++
		Lévomépromazine	NOZINAN®	+	+	–	++	++++	++	++	+++	+++	+++
		Flupentixol	FLUANXOL®	+	+	+	+++	++	++++	+++	++	++	++
		Zuclopenthixol	CLOPIXOL®	+	+	+	+++	+++	+++	++++	++	++	++
		Halopéridol	HALDOL®	+	+	+	+ / ++	++	++++	++++	++	++	+++
		Pimozide	ORAP®	–	–	–	+ / ++	++	++++	++	+++	++	++++
		Penfluridol	SEMAP®	–	–	+	++	++	+++	+++	+++	++	+++

10 EFFETS SECONDAIRES

fréquemment rencontrés sous
NEUROLEPTIQUES / ANTIPSYCHOTIQUES

ABILIFY®
Aripiprazole

SOLIAN®
Amisulpride

LEPONEX®
Clozapine

HALDOL®
Halopéridol

ZYPREXA®
Olanzapine

XEROQUEL®
Quétiapine

RISPERDAL®
Risperidone

TERCIAN®
Cyamémazine

LOXAPAC®
Loxapine

LARGACTIL®
Chlorpromazine

NOZINAN®
Lévomépromazine

Somnolence, fatigue

Éviter la conduite dans la mesure du possible.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Baisse de motivation

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Mouvements involontaires, contractures musculaires, crampes, tremblements

Négocier une diminution de dose, un changement de médicament, ou l'ajout d'un médicament correcteur anticholinergique.

Vertiges, palpitations, étourdissements, malaises, en se levant

Se lever très lentement.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Bouche sèche

Boire souvent de l'eau, sucer des glaçons, bonbons ou pastilles sans sucre, mâcher des chewing-gums sans sucre.
Négocier une diminution de dose, un changement de médicament, l'ajout d'un médicament correcteur (anétholtrithione : SULFARLEM®) ou d'un spray de salive artificielle.

Vision floue, difficulté à lire

Éviter la conduite dans la mesure du possible.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Constipation

Marcher, faire de l'exercice, manger beaucoup de fruits crus et de légumes, boire beaucoup d'eau notamment le matin à jeun.
Négocier une diminution de dose, un changement de médicament ou la prescription d'un médicament laxatif.

Prise de poids

Marcher, faire de l'exercice, manger beaucoup de fruits crus et de légumes, boire beaucoup d'eau notamment le matin à jeun.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

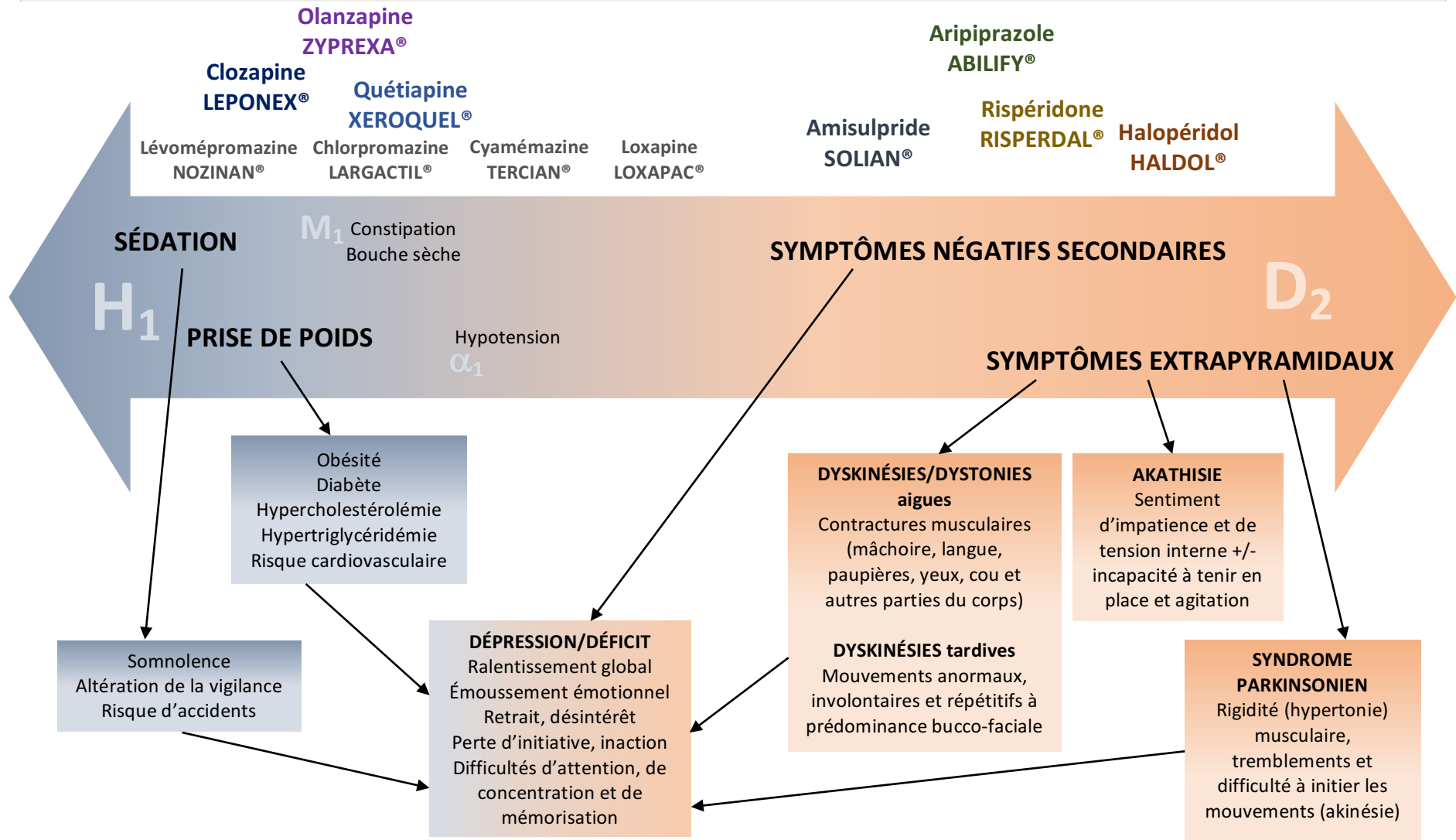
Impatiences, sensations d'inconfort

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Baisse de libido, frigidité, impuissance

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

NEUROLEPTIQUES EFFETS SECONDAIRES

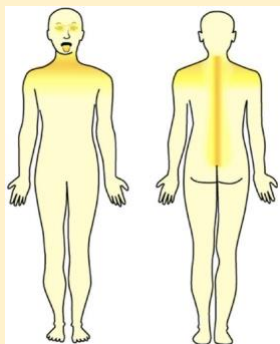


EFFETS SECONDAIRES EXTRAPYRAMIDAUX

INDUITS PAR LES NEUROLEPTIQUES / ANTIPSYCHOTIQUES

DYSTONIE AIGUË

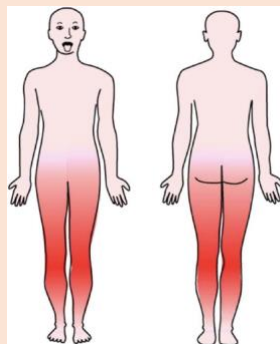
Contractions musculaires involontaires, soudaines, douloureuses et prolongées



J'ai les yeux qui plafonnent
J'ai du mal à articuler
Je n'arrive plus à ouvrir ou fermer la bouche, à avaler
J'ai la langue qui sort
J'ai un torticolis, j'ai mal au dos

AKATHISIE

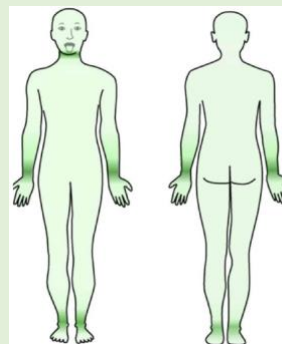
Sensation d'inconfort et de tension associée à un besoin impérieux de bouger



J'ai les jambes qui me démangent, qui picotent, qui se réveillent en permanence
Je bouillonne de l'intérieur
J'ai besoin de bouger tout le temps
J'ai envie de bondir hors de mon corps

PARKINSONISME

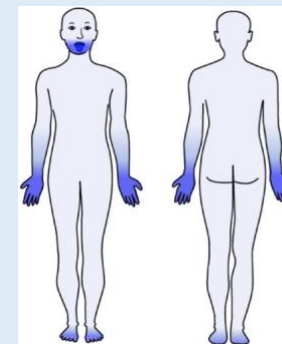
Ralentissement des mouvements, rigidité musculaire et tremblements



J'ai du mal à initier un mouvement quand je décide de bouger
Je me sens ralenti-e, figé-e, je bave
Je me sens raide
J'ai les mains, les doigts ou la bouche qui tremble dès que j'arrête de bouger

DYSKINÉSIE TARDIVE

Contractions musculaires lentes involontaires, stéréotypées et désordonnées



Je mâchonne, je mastique de façon automatique
J'ai la langue qui sort, je grimace
J'ai les mains qui bougent toutes seules
Mon corps se balance
Je piétine

INTÉRÊT DES « CORRECTEURS » ANTICHOLINERGIQUES

ex. tropatépine (LEPTICUR®), bipéridène (AKINETON LP®), trihexyphenidyle (ARTANE®, PARKINANE®)

OUI

En urgence

NON

Pas de preuve d'efficacité

BOF

Souvent risques > bénéfices

NON

Facteur favorisant et/ou aggravant

INTÉRÊT DE DIMINUER LA DOSE / CHANGER DE NEUROLEPTIQUE

ex. **très pourvoyeurs** : halopéridol (HALDOL®), loxapine (LOXAPAC®) vs. **peu pourvoyeurs** : quétiapine (XEROQUEL®), clozapine (LEPONEX®)

OUI

OUI

OUI

NON

Aripiprazole
ABILIFY®

COMMENT CHANGER DE NEUROLEPTIQUE ?

Tiré de [Stahl's Essential Psychopharmacology Online](#)
© 2015 Cambridge University Press.

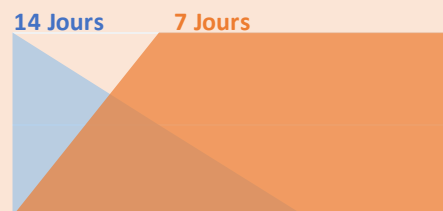
Risperidone : RISPERDAL®
Lurasidone : LATUDA®



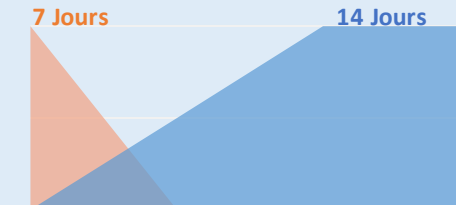
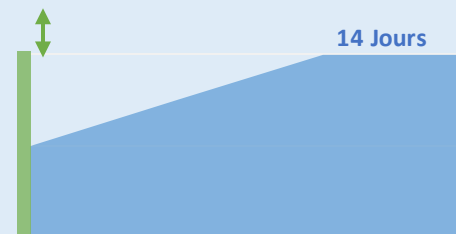
Olanzapine : ZYPREXA®
Quétiapine : XEROQUEL®



Risperidone : RISPERDAL®
Lurasidone : LATUDA®



Olanzapine : ZYPREXA®
Quétiapine : XEROQUEL®



La méthode la plus sûre reste généralement la **substitution croisée** sur 14 jours.
Les **PINES** sont à instaurer et à arrêter plus lentement que les **DONES** du fait de leurs activités anti-histaminiques, anticholinergiques et anti-adrénériques plus prononcées. Celles-ci exposent à davantage d'effets secondaires à l'instauration (sédation, hypotension, confusion, constipation, troubles visuels etc.) et à davantage de complications lors du sevrage (insomnie, agitation, rebond cholinergique etc.). L'interruption de la **clozapine** doit s'étaler sur au moins 4 semaines.
L'**aripiprazole** est à instaurer d'emblée à une dose plus élevée, et à interrompre sans décroissance de dose, ceci du fait de ses propriétés particulières (forte affinité antidopaminergique, agonisme partiel et demi-vie longue).



ARIPIRAZOLE

ABILIFY®

INDICATIONS



France

- **Schizophrénie** (âge > 15 ans)
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques (âge > 13 ans)
 - Prévention des récives maniaques



États-Unis

- **Schizophrénie** (âge > 13 ans)
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques
 - Épisodes mixtes
 - Prévention des récives
- **Épisode dépressif majeur**
 - En association à un antidépresseur
- **Trouble du spectre de l'autisme**
 - Irritabilité



Non officielles

- Trouble bipolaire
 - Épisode dépressif majeur
- Autres troubles psychotiques
- Trouble obsessionnel compulsif
- Troubles du comportement
 - Dans la démence
 - Chez l'enfant et l'adolescent
- Trouble du contrôle des impulsions

EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS



Akathisie ++

Impatiences, sensations d'inconfort, de tension intérieure
Anxiété



Insomnie +

Difficultés d'endormissement, de maintien du sommeil
Réveil précoce

Sédation

Fatigue
Somnolence

Symptômes extrapyramidaux

Tremblements, rigidité et contractures
musculaires

Nausées

Vomissements
Constipation

Prise de poids

Hyperglycémie, diabète
Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol

Hypotension orthostatique

Vertiges ou sensation de malaise en se levant
Tachycardie

À SAVOIR

- L'aripirazole est une molécule peu voire non sédatrice, ce qui la rend peu avantageuse (seule) dans les troubles qui s'accompagnent d'insomnie et d'anxiété mais avantageuse dans la plupart des autres cas.
- L'aripirazole ne favorise pas ou que peu la prise de poids (ainsi que le diabète et l'augmentation des taux de triglycérides et de cholestérol), ce qui constitue un avantage par rapport à la plupart des autres antipsychotiques.
- Les propriétés de l'aripirazole lui permettent de contrer les actions d'autres antipsychotiques, notamment certains effets secondaires (ex. hyperprolactinémie ou symptômes extrapyramidaux) lorsqu'il y est associé à faibles doses.

RISPÉRIDONE

RISPERDAL®

INDICATIONS



France

- **Schizophrénie**
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques
- **Maladie d'Alzheimer**
 - Agressivité persistante
- **Handicap intellectuel**
 - Trouble des conduites (âge > 5 ans)



États-Unis

- **Schizophrénie** (âge > 13 ans)
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques (âge > 10 ans)
 - Prévention des récurrences
- **Autres troubles psychotiques**
- **Trouble du spectre de l'autisme**
 - Irritabilité



Non officielles

- Trouble bipolaire
 - Épisode dépressif majeur
- Troubles anxieux sévères
- Trouble obsessionnel compulsif
- Troubles du comportement
- Trouble du contrôle des impulsions

EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS



Prise de poids +++

Hyperglycémie, diabète
Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol



Sédation +++

Fatigue
Somnolence

Symptômes extrapyramidaux

Tremblements, rigidité et contractures musculaires

Akathisie

Impatiences, sensations d'inconfort, de tension intérieure

Hyperprolactinémie

Troubles sexuels, du cycle menstruel, écoulement mammaire

Constipation

Bouche sèche

Troubles de l'accommodation visuelle

Hypotension orthostatique

Vertiges ou sensation de malaise en se levant

Tachycardie

À SAVOIR

- La rispéridone provoque davantage d'effets secondaires extrapyramidaux (tremblements, rigidité et contractures musculaires) que la plupart des autres antipsychotiques de seconde génération.
- La rispéridone augmente davantage le taux de prolactine que la plupart des autres antipsychotiques de seconde génération. Ceci peut devenir problématique en cas de désir de grossesse, de ménopause et/ou de risque d'ostéoporose.
- La fatigue et la somnolence peuvent devenir problématiques en journée, notamment en dehors des états de crise, lorsque la rispéridone est utilisée pour prévenir les rechutes.

OLANZAPINE

ZYPREXA®

INDICATIONS



France

- **Schizophrénie**
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques
 - Prévention des récives si réponse à l'olanzapine au cours d'un épisode maniaque



États-Unis

- **Schizophrénie** (âge > 13 ans)
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques (âge > 13 ans)
 - Épisodes dépressifs (avec fluoxétine, âge > 10 ans)
 - Prévention des récives
- **Épisode dépressif majeur**
 - En cas de résistance
 - Associé à la fluoxétine



Non officielles

- Autres troubles psychotiques
- Troubles du comportement
 - Dans la démence
 - Chez l'enfant et l'adolescent
- Trouble du contrôle des impulsions
- Personnalité borderline

EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS



Prise de poids ++++

Hyperglycémie, diabète
Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol



Sédation +++

Fatigue
Somnolence

Constipation

Bouche sèche

Troubles de l'accommodation visuelle

Hypotension orthostatique

Vertiges ou sensation de malaise en se levant

Tachycardie

Symptômes extrapyramidaux

Tremblements, rigidité et contractures musculaires

Akathisie

Impatiences, sensations d'inconfort, de tension intérieure

Hyperprolactinémie

Troubles sexuels, du cycle menstruel, écoulement mammaire

À SAVOIR

- L'olanzapine favorise davantage la prise de poids (ainsi que le diabète et l'augmentation des taux de triglycérides et de cholestérol) que la plupart des autres antipsychotiques.
- L'olanzapine peut devenir moins efficace chez les personnes qui débutent ou augmentent leur consommation de cigarettes et les effets secondaires peuvent augmenter chez les personnes qui diminuent ou interrompent leur consommation.
- Certaines données suggèrent une plus grande efficacité de l'olanzapine comparée à celle de la plupart des autres antipsychotiques, ce qui pourrait expliquer son utilisation fréquente en cas de symptômes résistants.

QUÉTIAPINE

XEROQUEL®

INDICATIONS



France

- **Schizophrénie**
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques
 - Épisodes dépressifs majeurs
 - Prévention des récurrences
- **Épisode dépressif majeur**
 - En cas de réponse insuffisante à un antidépresseur
 - En association à un antidépresseur



États-Unis

- **Schizophrénie** (âge > 13 ans)
- **Trouble bipolaire** (âge > 10 ans)
 - Épisodes maniaques
 - Épisodes dépressifs majeurs
 - Prévention des récurrences
- **Épisode dépressif majeur**
 - En cas de réponse insuffisante à un antidépresseur
 - En association à un antidépresseur



Non officielles

- Insomnie
- Troubles anxieux sévères
 - Trouble anxieux généralisé
 - Trouble de stress post-traumatique
- Autres troubles psychotiques
- Troubles du comportement
 - Dans la démence
 - Dans la maladie de Parkinson
- Trouble du contrôle des impulsions

EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS



Prise de poids +++

Hyperglycémie, diabète
Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol



Sédation ++++

Fatigue
Somnolence

Constipation
Bouche sèche
Troubles de l'accommodation visuelle

Hypotension orthostatique
Vertiges ou sensation de malaise en se levant
Tachycardie

À SAVOIR

- La quétiapine provoque beaucoup moins d'effets secondaires extrapyramidaux (tremblements, rigidité et contractures musculaires) que la plupart des autres antipsychotiques.
- La quétiapine est une molécule sédatrice, ce qui la rend plutôt avantageuse dans les périodes de crises ou les troubles qui s'accompagnent d'insomnie et d'anxiété.
- La fatigue et la somnolence peuvent cependant devenir problématiques en journée, notamment en dehors des états de crise, lorsque la quétiapine est utilisée pour prévenir les rechutes.

CLOZAPINE

LEPONEX®

INDICATIONS



France

- **Schizophrénie**
 - Résistance au traitement
 - Association à la maladie de Parkinson



États-Unis

- **Schizophrénie**
 - Résistance au traitement
 - Réduction du risque suicidaire



Non officielles

- Trouble bipolaire
 - Résistance au traitement
- Troubles neuro et/ou psychotiques
 - Résistance au traitement

EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS



Prise de poids +++++

Hyperglycémie, diabète
Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol



Sédation +++++

Fatigue
Somnolence

Constipation
Bouche sèche ou hypersialorrhée
Troubles de l'accommodation visuelle

Hypotension orthostatique
Vertiges ou sensation de malaise en se levant
Tachycardie
Myocardite



Neutropénie

Surveillance obligatoire du taux de globules blancs

À SAVOIR

- L'efficacité de la clozapine est supérieure à celle des autres antipsychotiques dans la schizophrénie mais elle n'est indiquée qu'en seconde intention en raison du risque de neutropénie.
- La clozapine est associée à une diminution du risque suicidaire dans la schizophrénie.
- La clozapine est plus sédatrice que la plupart des autres molécules antipsychotiques, la fatigue et la somnolence qui en découlent peuvent devenir problématiques durant la journée.
- La clozapine provoque beaucoup moins d'effets secondaires extrapyramidaux (tremblements, rigidité et contractures musculaires) que la plupart des autres antipsychotiques.

LOXAPAC® Loxapine	OU	TERCIAN® Cyamémazine
+	 Action sur l' anxiété	++
++	 Action sur les hallucinations et les idées délirantes	+
++	 Sédation Somnolence	+++
+	 Prise de poids	++
+	 Constipation Sécheresse buccale Troubles de l'accommodation visuelle	++
+	 Hypotension Vertiges Malaises	++
++	 Troubles neuromusculaires Spasmes, contractures Tremblements, impatiences	+
-	 Allongement QTc Torsades de pointes	++